PROTOCOLLO 78

Esercizi oculomotori

Migliorare il controllo occhio collo nei pazienti con vertigini o instabilità

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con vertigini o disturbi visivi	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Vertigini cervicogeniche
- ✓ Difficoltà di fissazione
- ✓ Dolore cervicale con sintomi visivi

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Fissazione

Fissa un bersaglio mentre muovi lentamente il capo.

2



FASE 2

Inseguimento

Segui con gli occhi un dito che si muove, capo fermo.

3



FASE 3

Saccadi

Sposta lo sguardo tra due bersagli.

4



FASE 4

Progressione

Aumenta velocità e ampiezza gradualmente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	1 minuto per esercizio
Serie	2
Frequenza	2 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Sintomi lievi e transitori sono accettabili
- ✓ Progressione lenta
- ✓ Ambiente sicuro

Errori da evitare

- ! Esercizi con vertigini intense
- ! Velocità eccessiva
- ! Esecuzione in piedi senza appoggio all'inizio

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Fissazione con movimento del capo	Fissare un bersaglio ruotando lentamente il capo	1 minuto, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** In presenza di vertigini, escludi sempre cause vestibolari centrali o periferiche con il medico.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.